



# HealthMatch

A camada de inteligência operacional do trabalho em saúde no Brasil

**Gestão e alocação inteligente de plantões** · SaaS + marketplace com IA

**Captação Pre-seed · R\$ 1,5 mi**   Junho 2026 · Beachhead: Fortaleza/CE

# Preencher um plantão ainda é um processo manual e caro



## Plantão descoberto

Vagas que ninguém preenche a tempo viram risco assistencial e multa contratual.



## Horas no WhatsApp

Coordenadores caçam profissionais em grupos, planilhas e telefonemas, um a um.



## Sem checagem

Credencial vencida, especialidade errada e conflito de agenda passam despercebidos.



## Margem opaca

Quem paga e quem recebe quanto? Sem dados, a operação perde dinheiro silenciosamente.

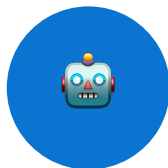
*O concorrente nº 1 não é um software — é a planilha e o grupo de WhatsApp.*

# Uma plataforma que preenche o plantão certo, sozinha



## Matching inteligente

Cruza especialidade, CBO, credencial, no-show e conflito de agenda — e ranqueia quem pode assumir.



## IA que negocia 24/7

Um agente conversa pelo WhatsApp, oferece o plantão e confirma — com humano no controle das ações críticas.



## Financeiro de margem

Recebíveis do cliente, pagáveis ao profissional e a margem da plataforma, com auditoria ponta a ponta.

**Resultado:** do plantão descoberto ao profissional confirmado em minutos, não em horas.

# Não é uma ideia: o produto já está construído e testado

## Já construído e testado

32/32

testes de API aprovados

14/14

regras de negócio validadas

~20

módulos de domínio

Pronto

para o primeiro piloto



### Pipeline de vagas e contratos

avulso, recorrente, cobertura, pool



### Candidaturas → alocações → escala

com controle de presença e no-show



### Credenciamento regulatório

CRM/COREN, CBO, RQE, documentos



### Omnichannel + auditoria + RBAC

WhatsApp/SMS/e-mail, white-label

# A janela abriu — e o modelo já é provado lá fora



## Saúde operacional ainda manual

A “última milha” do RH em saúde — escala e plantão — segue em planilhas.



## WhatsApp + IA maduros

Recrutamento conversacional automatizado a custo marginal quase zero.



## Pressão por conformidade

Setor público exige controle de presença e prestação de contas.



## Tese validada globalmente

Nomad, Trusted, Medely (EUA) e Patchwork (UK) captaram centenas de US\$ mi.

# Um mercado de bilhões, hoje sem dono digital

TAM

R\$ 15–20 bi

GMV de plantões/escalas de saúde no Brasil

SAM

R\$ 3–4 bi

Nordeste + cooperativas, hospitais privados e público

SOM

R\$ 150–300 mi

CE + cooperativas do NE capturáveis (3–5 anos)

◆ Estimativa bottom-up: nº de plantões × ticket médio (R\$ 1.300). Receita endereçável ≈ 10% do GMV (take-rate + SaaS).

# Híbrido: recorrência previsível + upside de marketplace



## SaaS — assinatura

MRR por conta institucional (cooperativa, hospital, órgão público).

**~R\$ 4.000** /conta/mês (ARPA)

Tiers: Essencial · Pro · Enterprise (white-label)



## Fee — intermediação

Take-rate sobre o GMV de cada plantão transacionado na plataforma.

**5–8%** do GMV (cons.→otim.)

GMV médio por plantão ♦ R\$ 1.300

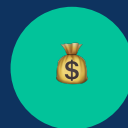
*MRR dá previsibilidade ao investidor; o take-rate captura o crescimento do volume.*

O DIFERENCIAL

# Nascemos com liquidez: a cooperativa-âncora

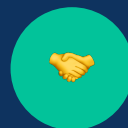
# 55.000

cooperados já contratualizados como oferta no dia  
1



## Investidor estratégico

Capital pre-seed + smart money do setor



## Cliente-âncora

Primeiro contrato e case de validação



## Oferta pronta

CAC de profissionais ≈ R\$ 0

*Resolve o “ovo e galinha” do marketplace — e abre a porta do sistema cooperativista nacional.*

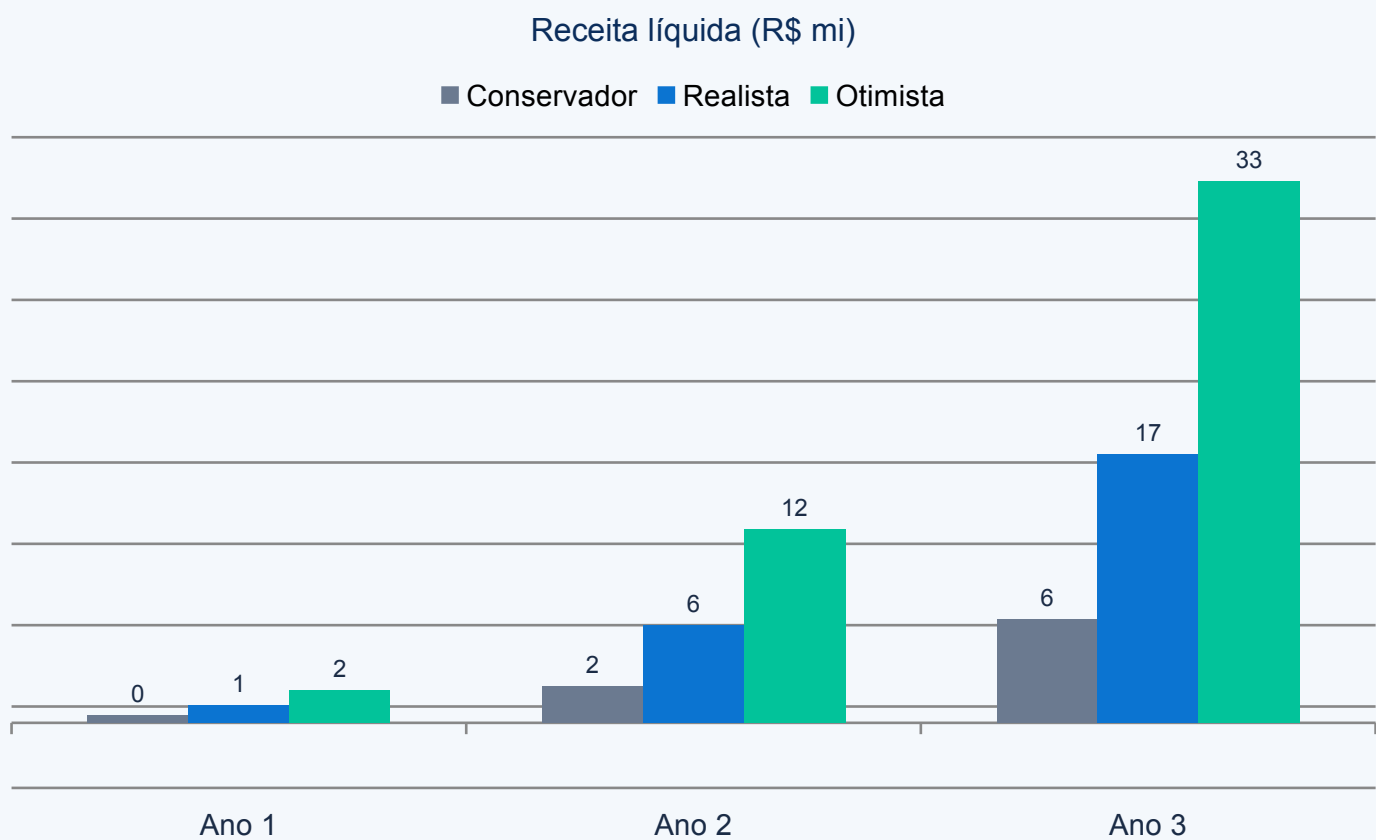


# Fragmentado, manual e sem um player de tecnologia

|                                    | Relacionamento | Matching + IA | Financeiro/margem | Marketplace |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| Status quo (WhatsApp/planilha)     | ✓              | ✗             | ✗                 | ✗           |
| Agências/cooperativas tradicionais | ✓              | △             | ✗                 | ✗           |
| Software hospitalar (HIS)          | △              | ✗             | △                 | ✗           |
| Marketplaces de saúde adjacentes   | ✗              | ✗             | △                 | △           |
| HealthMatch                        | ✓              | ✓             | ✓                 | ✓           |

✓ forte   △ parcial   ✗ ausente

# Receita líquida e caminho ao break-even



~mês 20–22

Break-even

+R\$ 3,2 mi (20%)

EBITDA Ano 3

R\$ 187 mi

GMV Ano 3

~68%

Margem bruta

◆ Cenário realista. Pré-lançamento: premissas de mercado a validar no piloto.

## Economia saudável — mesmo na visão SaaS-only

~7,7×

**LTV / CAC**

benchmark saudável > 3

~4,7

**Payback de CAC (meses)**

benchmark saudável < 12

12%

**Churn anual (logo)**

alto switching cost

R\$ 0

**CAC de profissionais**

via a cooperativa-âncora

*Reporto SaaS-only para ser defensável; com o take-rate por cliente, a economia blended é muito maior.*

# Do piloto ao break-even em ~24 meses

0–6 m

## Fundação & Âncora

- Fechar pre-seed
- Eng + CS/Ops; blindar IP/LGPD
- Hardening: multi-tenancy + billing
- Piloto na cooperativa-âncora

6–18 m

## Densidade regional

- Expandir dentro da âncora
- Abrir 2–3 cooperativas do NE
- 1º comercial + co-marketing
- Break-even ~mês 20–22

18–36 m

## Expansão de segmento

- Hospitais e redes privadas
- Piloto no setor público (UPAs)
- Inbound + indicações
- Preparar rodada seed

# Captamos R\$ 1,5 mi para ~20 meses de runway

## R\$ 1,5 mi

Pre-seed · SAFE com teto

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 55% | Produto & Engenharia     |
| 18% | GTM (Vendas & Marketing) |
| 10% | Infra & COGS             |
| 9%  | Jurídico / Compliance    |
| 8%  | Reserva                  |



### Produto pronto

construído e testado, pronto para implantar



### Distribuição única

a rede de cooperativas de saúde como esteira



### Liquidez no dia 1

55k cooperados de oferta, CAC ≈ 0



### Founder técnico

executa o roadmap; rodada monta o time



# O sistema operacional do trabalho em saúde no Brasil

Produto pronto · canal único · liquidez no dia 1. Vamos construir a categoria juntos.